

Приобретённый скрытый половой член & его коррекция

Информация для пациента · Когда половой член скрывается под кожей и как хирургия восстанавливает его

WARWIKI

Приобретённый скрытый половой член — состояние, при котором половой член **скрывается под кожей и жиром** нижней части живота, мошонки или бедра у взрослого. Это вызывает трудности с гигиеной, повторные кожные инфекции, проблемы с мочеиспусканием стоя и с половой жизнью. Это признанная, поддающаяся лечению реконструктивная проблема — операция позволяет освободить и восстановить половой член.

Об этом состоянии

«Приобретённый» означает, что состояние развилось во взрослом возрасте (в отличие от безвредного скрытого полового члена у некоторых детей). Частые причины: **лишний вес** и большой жировой фартук внизу живота, рубцы после обрезания или операций, хронический отёк кожи (**лимфедема**) и рубцующее кожное заболевание — **склерозирующий лихен**.

Состояние склонно к порочному кругу:

- Зажатая кожа остаётся влажной, **воспалется и инфицируется**.
- Моча, попадающая на зажатую кожу, усиливает раздражение и рубцевание.
- Гигиена, мочеиспускание и половая жизнь со временем ухудшаются.

Зачем нужна операция

Цель операции — **освободить половой член**, удалить поражённую кожу и восстановить здоровое покровное покрытие, чтобы вы могли мочиться стоя, соблюдать гигиену и вернуться к нормальной жизни — удовлетворённость результатом, как правило, высокая.

ТЕРМИНЫ

Скрытый (спрятанный) половой член

Половой член, скрытый под окружающей кожей и жиром.

Паннэктомия

Удаление нависающего жирового фартука нижней части живота.

Escutcheonectomy

Удаление жировой подушки над половым членом.

Кожный трансплантат

Здоровая кожа, перемещённая для покрытия ствола полового члена.

Склерозирующий лихен

Рубцующее кожное заболевание, способное вызвать или усугубить состояние.

Лимфедема

Хронический отёк кожи, приводящий к скрытию полового члена.

НУЖНО ЛИ СНАЧАЛА ПОХУДЕТЬ? Нередко — да. При скрытом половом члене, связанном с весом, снижение веса (иногда с направлением к бариатрическому хирургу) улучшает результат и долговременный эффект, поэтому врач может рекомендовать это до или одновременно с операцией. Сама операция обычно **удаляет жировой фартук** одновременно.

Как проходит операция

- 1 Половой член **освобождают** из рубцовой ткани и удерживающих его структур.
- 2 Поражённая или рубцовая кожа удаляется; ствол нередко покрывают **кожным трансплантатом**.
- 3 Нависающий жировой фартук удаляется (**паннэктомия / escutcheonectomy**); мошонка может быть скорректирована.
- 4 Операция иногда проводится в **несколько этапов**; устанавливается катетер, дренажи — норма.

Как подготовиться

- **Оптимизация веса** (возможно направление к бариатрическому хирургу) и **отказ от курения** — оба фактора существенно влияют на заживление.
- Сначала вылечите активную кожную инфекцию; следуйте инструкциям по анестезии.
- Организуйте помощь дома и время для восстановления — оно требует усилий.

После операции

- Ожидайте **госпитализации**, катетера и дренажей на некоторое время.
- Если использован трансплантат, **берегите его** — избегайте сидения и давления на эту область, как указано врачом.
- Уход за раной и постепенное возвращение к активности; контроль веса защищает результат.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры, нарастающее покраснение или гнойные выделения (инфекция)
- Трансплантат или рана **темнеют**, расходятся или сильно кровоточат
- Вы **не можете помочиться** или катетер прекратил дренирование

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Приобретённый скрытый половой член скрывается под кожей и жиром, вызывая проблемы с гигиеной, мочеиспусканием, инфекции и половые нарушения — и это поддаётся лечению.
2. Операция освобождает половой член, удаляет поражённую кожу (нередко с трансплантатом) и жировой фартук; может проводиться поэтапно.
3. Снижение веса и отказ от курения существенно улучшают результат. Обратитесь к врачу при высокой температуре, потемнении трансплантата или затруднённом мочеиспускании.